

RECURSO CÍVEL Nº 5073454-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ESTHER PIZARRO BATALHA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE - MAL DE ALZHEIMER E CARDIOPATIA GRAVE - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DO ENQUADRAMENTO DA DOENÇA DA PARTE AUTRA NO CONCEITO LEGAL DE ALIENAÇÃO MENTAL OU DE CARDIOPATIA GRAVE - PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE MAL DE ALZHEIMER, MAS SEM INDICAÇÃO DO SEU GRAU A FIM DE AFERIR SEU ENQUADRAMENTO COMO GRAVE - NA MESMA LINHA, HÁ PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CARDIOLÓGICA, MAS SEM COMPROVAÇÃO DO SEU ENQUADRAMENTO NO CONCEITO TÉCNICO-PERICIAL DE CARDIOPATIA GRAVE - ROL LEGAL TAXATIVO - NECESSIDADE DE SE ATESTAR E ENQUADRAR, DE MODO FUNDAMENTO E CIRCUNSTANCIADO, AS PATOLOGIAS DA PARTE AUTORA COMO ÀQUELAS PREVISTAS NA NORMA ISENTIVA POR EXPERT NA MATÉRIA, ESPECIFICAMENTE PARA FINS DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE UNIÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, para determinar a produção de prova pericial sobre a parte autora, sobre a documentação médica apresentada e sobre outros exames que a autora venha a apresentar no prazo a ser assinalado pelo juízo. Deverá o perito esclarecer se a situação da autora enquadra-se no conceito técnico pericial de alienação mental e/ou cardiopatia grave para fins do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5073454-16.2024.4.02.5101

510015507449 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5073454-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ESTHER PIZARRO BATALHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento do direito à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria e de pensão, bem como restituição de valores pagos recolhidos na fonte a este título, sob a alegação de estar acometida de Mal de Alzheimer e Miocardiopatia Grave (evento 1, LAUDO5).

O juízo de origem julgou **procedente o pedido.**

Em sede recursal, a Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença, ante ausência de enquadramento categórico da patologia do autor no art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88.

É o relatório. Decido.

VOTO

A autora realizou prévio requerimento administrativo, mas este não foi analisado tempestivamente.

No que tange à isenção de imposto por doença grave, limita-se a mesma à incidência do disposto no art. 6.º da Lei n.º 7.713/88, o qual preceitua nos seguintes termos:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:(...)"

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os **percebidos pelos portadores de** moléstia profissional, tuberculose ativa, **alienação mental**, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, **cardiopatia grave**, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004). "GRIFOS NOSSOS

Quanto à presença da doença o juízo considerou que (evento 44, SENT1):

"O(a) Autor(a) comprova que recebe pensão e proventos de aposentadoria pagos pelo INSS (7.1/7.5), bem como que é portador(a) de Alzheimer (evento 1.5).

*O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece que a ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de **neoplasia maligna**."*

Pois bem, **a neoplasia maligna não foi indicada como fundamento na petição inicial**. Seguindo, o Alzheimer, por si só, não é uma das doenças previstas no rol taxativo da norma isentiva. Para que o Alzheimer configure uma das patologias isentivas deve ser comprovado que, no caso concreto, ele levou à **alienação mental**.

Especificamente quanto ao mal de Alzheimer, entre outros estados mentais, tem-se pela isenção por força da alienação mental provocada pela doença. Este entendimento encontra respaldo técnico na orientação da própria Administração Pública, conforme o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 3ª EDIÇÃO Brasília - DF - 2017, elaborado pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, vinculado ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

CAPÍTULO VI - DOENÇAS ESPECIFICADAS EM LEI

*O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento como **alienação mental**, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo médico pericial, constará apenas a expressão "alienação mental".*

Crerios de Enquadramento

A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as condições abaixo discriminadas: 1. Seja grave e persistente; 2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento; 3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação; 4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.

São Passíveis de Enquadramento

*1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais; 2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais; 3. Estados **demenciais de qualquer etiologia** (**vascular, Alzheimer, doença de Parkinson, etc.**); 4. Retardos mentais graves e profundos.*

(Fonte: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/38801/5/Manual_Pericia_Medica_2017.pdf)

Portanto, existem critérios técnico-científicos que servem para, a partir de informação exarada de modo fundamentado e circunstanciado por médico, diagnosticar um transtorno mental como alienação mental, especialmente para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

É imprescindível a conclusão médica enquadrando a situação da parte autora como alienação mental, ou seja, caracterização de quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Deve ser demonstrado que o indivíduo é incapaz de responder por seus atos na vida civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER". ISENÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. No REsp n. 1.814.919/DF, repetitivo, a Primeira Seção reafirmou entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 só alcança os portadores das moléstias lá elencadas que estejam aposentados. E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116.620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas.

3. A Lei n. 7.713/1988, em seu art. 6º, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer. **Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico da Segunda Turma.**

4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto **eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na via do especial.**

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.082.632/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

O documento médico apresentado afirma que a parte autora possui diagnóstico de ***"de miocardiopatia grave e doença de alzheimer avançada em tratamento desde 2017. No momento encontra-se restrita ao leito com atividades psico-sociais limitadas e necessita de cuidados multidisciplinares e familiares contínuos."***, não é categórica na inclusão das patologias da autora em alguma dessas categorias isentivas para fins de não exação do imposto de renda sobre os proventos da autora nos termos dono art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88. Bem como **não é acompanhada por exames médicos e outras provas além da mera declaração do médico.**

Certificada, portanto, a condição de Alzheimer, aliada ao início provável de diversas outras limitações cognitivas e motoras, conforme entendimento jurisprudencial, pode ser equiparada a situação da autora à alienação mental. **A questão é que a alienação mental, para que seja como tal caracterizada, demanda quadro de incapacidade para atos da vida civil o que, de fato, não se extrai dos laudos médicos.**

Em igual sentido, inexistente informação categórica e fundamentada acerca do enquadramento da **miocardiopatia grave** da autora como cardiopatia grave, a qual também possui seus critérios técnico-periciais para diagnóstico. A **autora possui inegável problema cardíaco, mas o juízo não possui elementos concretos e científicos para tipificá-lo como CARDIOPATIA GRAVE**, que é a doença que assegura a isenção, posto que não é todo e qualquer problema cardíaco que a assegura.

Nesse sentido, a conclusão exposta na II Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (<https://diretrizes.cardiol.online/>):

"É correta a afirmativa de Besser 46 de que 'É preciso não confundir gravidade de uma cardiopatia com Cardiopatia Grave, uma entidade médico-pericial'. Essencialmente, a classificação de uma Cardiopatia Grave não é baseada em dados que caracterizam uma entidade clínica, e sim, nos aspectos de gravidade das cardiopatias, colocados em perspectiva com a capacidade de exercer as funções laborativas e suas relações como prognóstico de longo prazo e a sobrevivência do indivíduo. Verifica-se uma dificuldade ainda maior na extensão do benefício aos inativos (aposentados), já que estes indivíduos não mais exercem a atividade laborativa (esforço físico), um dos fatores considerados importantes no julgamento pericial de incapacitação. Embora os procedimentos intervencionistas e cirúrgicos sejam considerados na medicina pericial apenas parte da estratégia terapêutica aplicada aos doentes e, obviamente, não sejam considerados uma doença propriamente dita, sabemos que a cada intervenção corresponde uma enfermidade cardiovascular importante subjacente, que deverá ser avaliada em relação à ação deletéria e às deficiências funcionais que se possam imputar sobre a capacitação laboral do doente, como em todas as cardiopatias. Sabemos, também, que, num grande número de pacientes, a cirurgia ou o procedimento intervencionista alteram efetivamente a história natural da doença para melhor, modificando radicalmente a evolução de muitas doenças e, conseqüentemente, a categoria da gravidade da cardiopatia, pelo menos no momento da avaliação. Este é o conceito dinâmico de "reversibilidade" da evolução das cardiopatias, que deixam de configurar uma condição de Cardiopatia Grave observada anteriormente. De qualquer forma, nunca devemos achar, de antemão, que pacientes submetidos a quaisquer das intervenções mencionadas têm a condição médico-pericial de Cardiopatia Grave, como erroneamente interpretado por muitos. Considera-se um servidor (ativo ou inativo) como portador de Cardiopatia Grave, quando existir uma doença cardíaca que acarrete o total e definitivo impedimento das condições laborativas, existindo, implicitamente, uma expectativa de vida reduzida ou diminuída, baseando-se o avaliador na documentação e no diagnóstico da cardiopatia."

O juízo confunde os conceitos de gravidade de uma cardiopatia com a entidade médico-pericial da cardiopatia grave do dispositivo isentivo.

Considerando que o rol de doenças contido no dispositivo legal é **taxativo (numerus clausus)**, vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, é necessária a comprovação efetiva, ou da alienação mental de per si ou da neoplasia maligna por meio de perícia do juízo.

Entende-se, portanto, que a sentença deve ser anulada, para que haja certificação médica pelo perito do juízo (profissional imparcial) quanto à efetiva presença de alienação mental e/ou cardiopatia grave em termos **técnico periciais**, de forma fundamentada e circunstanciada, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE UNIÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA**, para determinar a **produção de prova pericial sobre a parte autora, sobre a documentação médica apresentada e sobre outros exames que a autora venha a apresentar no prazo a ser assinalado pelo juízo**. Deverá o perito esclarecer se a situação da autora enquadra-se no conceito técnico pericial de alienação mental e/ou cardiopatia grave para fins do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5073454-16.2024.4.02.5101

510015507448 .V5